



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : نبيله محمد حسن عرابي

المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : منشيه ناصر العنوان : --

رقم البطاقة : 27604102501181 رقم التليفون : 01120416233 تاريخ تسجيل الإستمارة : 10-10-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 10-04-1976 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونك [14157]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة. تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / أ.د. / أ.د. / د. / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نبيله محمد حسن عرابي National ID: 27604102501181	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

نبيهه
محمد حسن عرابي
ج عبدالخالق عبدالتواب
ملشيه ناصر - القاهرة

١٩٧٦/٠٥
IA2889036

٢٧٦.٤١.٢٥.١١٨١

٢٠١٩/٠٥ ٢٧٦.٤١.٢٥.١١٨١
ربة منزل

أنثى
مسلمة
متزوجة
يسرى محمد عبدالحميد محمد

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/٠٥/١٠

١

Patient Name	: الأمل / فريدة محمد حسن	Request No.	: 13000130
Patient No.	: 27604102501181	Request Date	: 13/07/2023
Path No.	: 2219/23	Verification Date	: 24/07/2023
Sex	: Female	Financial Category	: فئة الدولة - عام
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: amawa mohamed you

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 13/7/2023, 10:05 am.

Gross Examination:

- Four grayish white tissue cores up to 1cm, totally submitted.
Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

Microscopic Examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- Ductal carcinoma in situ: Focal.
- Percent of invasion: No.
- Angioinvasion: No.
- Additional pathologic findings: N/A.

ER: Strong nuclear reaction in 30% of tumor cells (Allred score 6/8)
PR: Moderate nuclear reaction in 50% of tumor cells (Allred score 6/8)
Her-2: strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+)
Ki 67: 15 % nuclear reaction in tumor cells
Positive control showed appropriate reactivity

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy.
Invasive duct carcinoma G II with focal DCIS.

Verified by:
Christina Magdy

Printing Date: 05.08.2023 09:54:29

Page 1 of 2

Printed By: amawa mohamed you

Name: نبيله محمد حسن عرابي		
MR. : 7420		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحية طيبة وبعد,,		
إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:	رقم طبي:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
تاريخ وساعة الدخول :	تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient presented for administration of femara and received supportive treatment for three months in preparation for a dental consultation related to zometa therapy. The patient is documented as being on adjusted femara since February 2024 and attended today for zometa administration following laboratory workup that included a breast ultrasound, non-contrast computed tomography of the chest, and an abdominal-pelvic ultrasound (APUS). Multidisciplinary discussion in March 2024 recommended neoadjuvant chemotherapy (NACT) with the TCHP regimen for six cycles, followed by a left total mastectomy (LT MRM) with pathology reported as ypTis. The plan includes continuation of PHESGO for up to one year and consideration of endocrine therapy (ET) based on menopausal status. In June 2026 imaging demonstrated a BI-RADS 2 finding, and a follow-up ultrasound was performed; femara was continued without interruption, and supportive care was provided for three months with a chest CT ordered. The next scheduled visit is 29 October 2026.		
تحريراً في ,		
التاريخ :	الوقت :	19-09-2026
الطبيب المعالج :		Reham Ahmed Fathy Ibrahim
يعتمد ,		



Patient Name: Nabila Mohamed Hassan Orabi	Date : 07/11/2024
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 3910/2023	Pat. ID: 45477

**NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

1. Chest:

- MRM of the left breast with no operative bed lesions or collection.
- Right breast retroareolar focal parenchymal distortion with smudged surrounding fat planes.
- Right axillary level I enlarged lymph nodes the largest measures 2x1 cm.
- Left upper lobe subpleural atelectatic bands and reticulations are seen, Likely post radiation sequel.
- Bilateral few tiny partially calcified nodules are seen ranging from 2-3 mm.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is seen mildly enlarged with homogenous CT texture. Shows no definite focal lesions or contour irregularities, on non-contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. The scanned skeleton:



Patient Name: Nabila Mohamed Hassan Orabi	Date : 20/10/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 2910/2023	Pat. ID: 45477

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The right breast is scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Walaa Abdelazez

20/10/2024 4:05 PM

Patient's Name: Nabila mohamed Hasan Oraby

Date: 07/08/2023

WHOLE BODY PET/CT EXAMINATION

Clinical history:-

- 47 years old female, a case of recently diagnosed left breast cancer (13/07/2023).

Reason of study:

- Status evaluation.

Technique:-

- Approximately one hour after the IV injection of the radiopharmaceutical, whole PET-CT was acquired from the skull base to mid-thigh with the arms extended above the head.
- CT was acquired for anatomic localization, attenuation correction, and diagnostic purposes.
- Data were processed and displayed according to departmental protocol.
- Calculation of SUV_{max}. Would be done within the region's of interest whenever necessary ($SUV \geq 3.0$) that is equivalent to the liver SUV_{max}. (Internal reference organ).
- Radiopharmaceutical: F-18-FDG 8 mCi injected I.V.

Nabila mohamed Hasan Oraby



Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	: الأستاذة / نبيلة محمد حسن	Request No.	: 13004081
Patient No.	: 27604102501181	Request Date	: 03/02/2024
Path No.	: 466/23	Verification Date	: 28/02/2024
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Comment: Regrossing for further lymph nodes is in proess, if ant nodes detected, it will be released in addendum report.

Prof. Dr. Iman Goda.
Dr. Heba Hassan.

Signature
Dr. Marwa Mahmoud

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Printing Date : 28/02/2024 13:07:53

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mizr El Qadima- Cairo, Egypt

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]



Patient Name	: الأستاذ / نبيلة محمد حسن	Request No.	: 13004081
Patient No.	: 27604102501181	Request Date	: 03/02/2024
Path No.	: 466/23	Verification Date	: 28/02/2024
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.

Nature Specimen: Left modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:

- * Procedure: Left MRM measured 23x15x5 cm with covering skin ellipse measured 16x8 cm.
- * Tumor extent: A greyish white firm tumor bed site.
- * Size: 6 x3.5x3 cm.
- * Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
- * Distance from margins: 1 cm away from deep margin.
- * Lymph nodes number and size: Multiple L.Ns measured up to 1.5x1 cm.

Microscopic Examination:

- * Histological type: No residual viable tumor tissue.
- * Ductal carcinoma in situ: Focal.
- * Skin involvement: Free nipple and areola.
- * Lymph node involvement: 0/6
- * Resection Margins: Free margins.
- * Histologic response to therapy: Complete pathological response.

Diagnosis:

Left breast cancer post NACT, MRM specimen:

Complete pathological response in previously diagnosed invasive duct carcinoma, No residual viable invasive tumor tissue.

Free margins.

Free nipple and areola.

- (Lymph nodes)

- Stage: ypTis.

Verified by :

Dr.Marwa mahmoud

Printing Date : 28/02/2024 13:07:53

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youssef



جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية

نبيله
 محمد حسن عرابي
 ج عبدالحافظ بن عبدالتواب
 منشيه لناصر - القاهرة

١٩٧٦/٠٥
 ٢٧٦.٠٤.١٠.٢٥.١١٨١
 1A2889036

DM

٢٠١٩/٠٥ ٢٧٦.٠٤.١٠.٢٥.١١٨١
 ربة منزل
 أنثى
 يسرى محمد عبدالحامد محمد
 متروجة
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/٠٥/١٠

١